

Vértigo Posicional Paroxístico Benigno (VPPB)

1. Introducción y relevancia clínica

El **vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB)** es la **causa más frecuente de vértigo periférico** en adultos.

Se caracteriza por **episodios breves de vértigo rotatorio desencadenados por cambios de posición cefálica**, como girar en la cama, mirar hacia arriba o agacharse.

El cuadro se debe al **desplazamiento de otoconias (cristales de carbonato de calcio)** desde el utrículo hacia los canales semicirculares, lo que produce estimulación anómala del sistema vestibular.

Relevancia clínica

- Representa **>30% de los casos de vértigo periférico**.
 - Afecta más a **mujeres mayores de 50 años**.
 - Suele ser **autolimitado**, pero recidivante.
 - Su diagnóstico es clínico, y el tratamiento se basa en **maniobras físicas simples**, sin necesidad de fármacos.
 - Es importante distinguirlo de causas **centrales** o **potencialmente graves** de vértigo.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Fisiología vestibular normal

El oído interno posee tres **canales semicirculares** (anterior, posterior y horizontal) llenos de **endolinfa**, que detectan los movimientos angulares de la cabeza.

Las **máculas** del utrículo y sáculo detectan aceleraciones lineales gracias a la presencia de **otoconias** (pequeños cristales de carbonato de calcio).

2.2 Fisiopatología del VPPB

El VPPB ocurre por **desprendimiento de otoconias del utrículo**, que migran hacia uno de los canales semicirculares, generalmente el **posterior (80–90%)**.

Dependiendo de su localización:

Tipo	Mecanismo	Localización	Características
Canalitiasis	Otoconias libres en el canal	Posterior o lateral	Vértigo breve (<1 min) al mover la cabeza
Cupulolitis	Otoconias adheridas a la cúpula	Menos frecuente	Vértigo más prolongado, nistagmo persistente

El movimiento de las otoconias provoca **corrientes endolinfáticas aberrantes**, generando una falsa sensación de movimiento rotatorio (vértigo).

2.3 Factores de riesgo

- Edad avanzada.
- Traumatismo craneal.
- Inmovilización prolongada (hospitalización).
- Neuronitis vestibular previa.
- Migraña vestibular.
- Osteopenia u osteoporosis (en mujeres posmenopáusicas).

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Cuadro clínico típico

Síntoma	Características
---------	-----------------

Vértigo rotatorio breve	Dura segundos (<60 s), intenso, desencadenado por cambios posicionales.
Sin hipoacusia ni tinnitus	Diferencia clave con enfermedad de Ménière o neuritis vestibular.
Náuseas o inestabilidad	Pueden acompañar las crisis.
Asintomático entre episodios	No hay síntomas persistentes.

Desencadenantes típicos:

- Girar en la cama.
- Mirar hacia arriba (colgar ropa, alcanzar objetos).
- Agacharse.
- Cambiar de posición bruscamente.

3.2 Examen físico: Maniobras diagnósticas

A. Maniobra de Dix-Hallpike

- Paciente sentado, se gira la cabeza 45° hacia el oído a explorar.
- Se recuesta rápidamente con la cabeza extendida 30° fuera de la camilla.
- Observación de **nistagmo y vértigo característicos**.

Hallazgos:

- Latencia de 1–5 segundos.
- Nistagmo **rotatorio y ascendente** (si afecta canal posterior).

- Duración <60 segundos.
- Fatigabilidad (disminuye al repetir la maniobra).

B. Maniobra de rotación supina (Pagnini-McClure)

- Evalúa el **canal horizontal**.
- Paciente en decúbito dorsal, cabeza elevada 30°, girada rápidamente a ambos lados.
- Nistagmo **horizontal geotrópico o ageotrópico**, según el lado afectado.

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferencias clave
Neuronitis vestibular	Vértigo prolongado (días), sin desencadenantes posicionales.
Enfermedad de Ménière	Vértigo prolongado (horas) + hipoacusia + tinnitus.
Migraña vestibular	Vértigo variable, asociado a cefalea o fotofobia.
Accidente cerebrovascular vertebrobasilar	Vértigo persistente con signos neurológicos (ataxia, diplopía).
Fístula perilinfática	Vértigo post-esfuerzo o trauma.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Diagnóstico clínico

El diagnóstico de VPPB es **clínico**, basado en:

1. Episodios breves de vértigo posicional.
 2. Nistagmo característico en maniobra de Dix-Hallpike o McClure.
 3. Ausencia de síntomas auditivos o neurológicos.
-

4.2 Exámenes complementarios

Solo se solicitan en casos atípicos o refractarios:

- **Audiometría:** descartar hipoacusia asociada.
 - **RM encéfalo con gadolinio:** si vértigo prolongado o signos neurológicos.
 - **Pruebas vestibulares (vHIT, VNG):** en casos persistentes o diagnósticos diferenciales difíciles.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Objetivos

- Reposicionar las otoconias desprendidas.
 - Prevenir recurrencias.
 - Educar al paciente sobre el curso benigno y autolimitado del cuadro.
-

5.2 Maniobras terapéuticas

El **tratamiento de elección** es **físico**, mediante maniobras de reposicionamiento canalicular.

La farmacoterapia no modifica la evolución y solo se usa para aliviar síntomas asociados.

A. Canal posterior (más frecuente)

Maniobra de Epley (reposición canalicular):

1. Iniciar en posición de **Dix-Hallpike positiva** (vértigo).
2. Mantener 30–60 segundos hasta cesar síntomas.
3. Girar lentamente la cabeza 90° hacia el lado opuesto.
4. Luego girar el cuerpo al mismo lado, mirando hacia el suelo.
5. Mantener y reincorporar lentamente.

Éxito >80% con una aplicación.

Repetir si persisten síntomas.

B. Canal horizontal

Maniobra de Lempert (“barbecue roll”):

- Paciente en decúbito supino.
- Girar la cabeza 90° hacia el lado sano cada 15 segundos, hasta completar un giro de 360°.

C. Canal anterior (raro)

- **Maniobra de Yacovino o Epley modificada.**

5.3 Tratamiento farmacológico (sintomático)

Solo si vértigo o náuseas intensas:

- **Dimenhidrinato 50 mg VO c/8h** (por 2–3 días).
- **Diazepam 5 mg VO c/12h** (sedante vestibular corto plazo).

Evitar uso prolongado para no interferir con compensación vestibular.

5.4 Educación y medidas preventivas

- Explicar que es **benigno y autolimitado** (remite en semanas o meses).

- **Evitar movimientos bruscos de cabeza** durante los primeros días postmaniobra.
- Dormir con **cabeza elevada 30°** por 48 horas.
- Realizar ejercicios de habituación (Brandt-Daroff) en caso de recurrencia.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Recurrencias	En 15–20% anual, sobre todo en ancianos o postraumáticos.
Caídas o accidentes	Por pérdida momentánea del equilibrio.
Ansiedad o miedo al movimiento	Asociado a vértigo recurrente.

Pronóstico:

Excelente. La mayoría mejora con una o dos maniobras.

Recurrencias responden al mismo tratamiento.

No se asocia a hipoacusia ni daño neurológico.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Vértigo breve (segundos) + desencadenado por posición + sin hipoacusia = VPPB.**
2. La **maniobra de Dix-Hallpike positiva** confirma el diagnóstico.

3. El **canal posterior** es el más afectado.
 4. El tratamiento es **maniobra de Epley**, no fármacos.
 5. Si vértigo dura **horas o días**, considerar otra etiología (Ménière, neuronitis).
 6. Evitar vestibulosupresores crónicos, retrasan compensación.
-

Errores comunes

- Indicar antivertiginosos de forma prolongada.
 - Diagnosticar Ménière ante cualquier vértigo.
 - No realizar maniobra de Dix-Hallpike en la evaluación inicial.
 - No educar al paciente sobre recurrencias.
 - Sospechar causas centrales sin descartar VPPB.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **VPPB** es la causa más frecuente de **vértigo periférico**.
2. Se produce por **desplazamiento de otoconias** hacia los canales semicirculares.
3. Cursa con **vértigo breve (<1 min)**, **posicional** y **sin hipoacusia**.
4. La **maniobra de Dix-Hallpike** confirma el diagnóstico (nistagmo típico).
5. El **tratamiento de elección** es la **maniobra de Epley**.
6. La farmacoterapia es solo **sintomática y transitoria**.
7. El **pronóstico es excelente**, aunque puede recurrir.